

日本机构养老中的岗位、职业细分与工作拆解

执行摘要

日本的机构养老确实存在相当细致的**职业分工、流程标准化和任务拆解**，但需要先修正一个关键认识：**日本并不是普遍实行“一个护理员只负责喂饭、另一个只负责排泄、另一个只负责洗澡”的流水线式微岗位制度**。法规首先把人员分成**介護職員、看護職員、医师、药剂师、康复专业人员、营养师、介護支援専門員、相談員**等专业边界；在直接身体护理内部，**介護職員**通常仍会综合承担同一老人或同一单元的**进食、排泄、沐浴、移乘、夜间巡视和记录**。以**介護医療院**为例，厚生劳动省的制度明确以“**看護・介護チーム**”和**交替班次**组织服务，而不是按照单一动作设置独立职业。¹

真正值得借鉴的“**颗粒化**”主要发生在三个层面：**第一，把一次护理拆成标准动作和风险检查点；第二，把医疗、康复、营养、社会工作、照护计划等交给不同持证专业人员；第三，把铺床、清扫、配膳、餐后收拾、物品补充等非核心工作从介護職員身上剥离给“介護助手”等辅助人员**。厚生省近年的生产力提升项目就明确将**食事准备、片付け、清扫、ベッドメイク**等作为**介護助手**可承接的任务；个别先进机构甚至曾将现场工作拆成约百项任务，但这是运营创新案例，并非全日本统一岗位制度。²

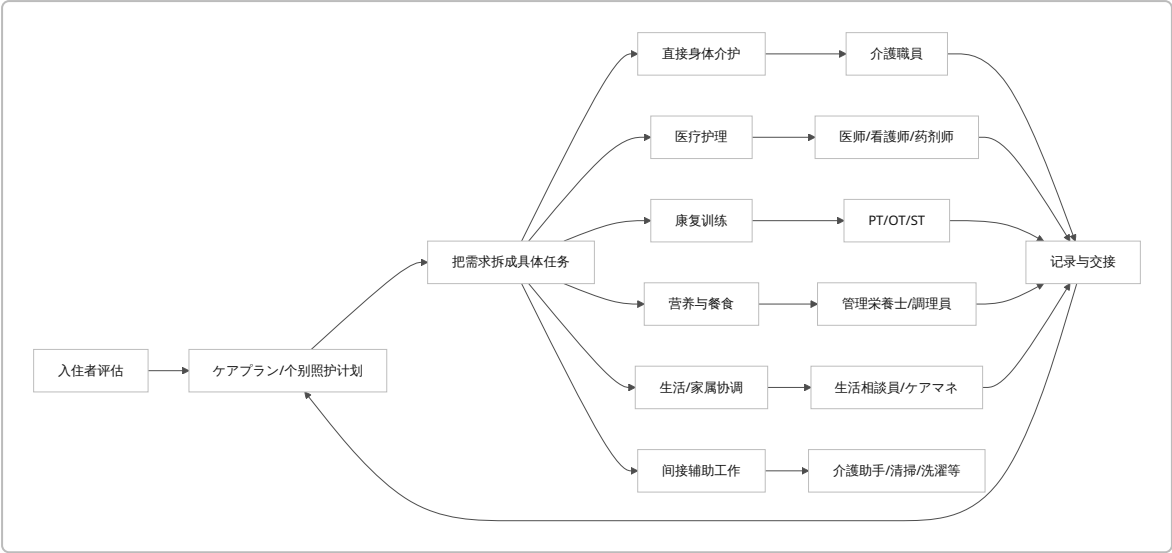
本报告覆盖**特別養護老人ホーム（特养）、介護老人保健施設（老健）、介護医療院以及認知症対応型共同生活介護（グループホーム）**。用户提到的**介護療養型医療施設**已经在**2024年3月31日退出制度，2024年4月1日**起转向**介護医療院或医院、诊所等形态**，因此以下以**介護医療院**作为当前制度对应物。³

研究范围与分工逻辑

四类主要机构的岗位结构并不完全相同。

机构类型	核心定位	岗位结构特点
特別養護老人ホーム（特养）	长期生活照护、重度失能老人生活场所	介護職員是主体；配看護職、生活相談員、ケアマネ、功能训练、营养等。法定核心是 介护+护理人员 的配置。 ⁴
介護老人保健施設（老健）	医疗管理、康复、提高ADL并促进回家	除介護職、看護職外， 医师、PT/OT/ST、支援相談員 的作用明显更大。看護+介護合计原则上至少约3名入住者对应1 FTE。 ⁵
介護医療院	长期医疗+长期生活照护+看取	医疗专业人员最齐全，包括 医师、药剂师、看護師、康复、营养等 ； I型医疗配置 明显高于普通养老设施。 ¹
認知症グループホーム	小单元认知症共同生活	以 介護従業者、計画作成担当者、管理者 为核心； 日间3名入住者对应1名介护人员，夜间原则上每单元1人 。 ⁶

因此，日本更接近下面这种组织方式：



这也是理解日本“细分”的关键：拆得很细的是任务和标准，不一定把每一个细步骤都变成一个独立职业。厚劳省的人员标准本身仍以多专业团队和班次为基本组织单位。⁷

工作项目与微步骤

下表是依据日本机构人员配置标准、厚劳省生产力提升资料以及常见施設护理流程所做的操作层面归纳。它不是一张全国统一的“岗位动作法定清单”，而是更接近实际设施如何把照护计划转成SOP。尤其是直接身体护理，同一个介護職員往往连续完成若干步骤；医疗判断、康复评估、营养设计等则明显由专业岗位接管。⁸

其中表内“介护资格”指：施設介護職員岗位本身并非全部要求持介護福祉士国家资格；介護福祉士、実務者研修、介護職員初任者研修是最常见的资格/培训层级。对没有相应医疗、福祉资格而从事介护业务的人员，2024年4月以后原则上要求接受認知症介護基礎研修，新入职人员存在一定培训犹予期。⁹

工作项目	可操作微步骤	通常负责职业	必需/常见资格	直接护理
沐浴	入浴前询问状态、观察面色、确认当天是否适合入浴	介護職＋看護職；高风险判断由看護職	介护资格；看護師/准看護師免許	是
沐浴	更衣、移动至浴室、轮椅/升降浴槽转移	介護職員	介护资格；移乘培训	是
沐浴	洗身、洗发、局部清洁，同时观察皮肤、压疮、伤口	介護職員；异常转看護職	介护资格	是
沐浴	擦干、更衣、补水、浴后状态确认并记录	介護職；异常由看護職评估	同上	是
排泄护理	判断如厕时间、尿意/便意、是否可自行行走	介護職員	介护资格	是
排泄	移乘马桶/便器、稳定坐姿、必要时衣物处理	介護職員	介护资格	是
排泄	阴部清洁、尿布/纸裤更换、皮肤护理	介護職員	介护资格、感染控制培训	是

工作项目	可操作微步骤	通常负责职业	必需/常见资格	直接护理
排泄	记录尿量、便性状、次数、异常出血/腹泻等并上报	介護職→看護職	介护资格；护理允许负责临床判断	是
进食	核对饮食种类、禁忌、食物形态、吞咽等级	管理栄養士＋看護職＋ST；介護職执行核对	管理栄養士/栄養士、ST、看護師等	部分
进食	调整座位、躯干和头部姿势、餐具、围裙	介護職員	介护资格	是
进食	一口量、速度控制、观察咀嚼/吞咽、咳嗽和误吸征象	介護職；高风险由ST/看護職介入	介护资格；ST/看護专业资格	是
进食	记录摄入量、水分量；餐后口腔清洁	介護職員	介护资格	是
服药	处方、停药、换药及剂量决定	医师	医師免許	是
服药	调剂、一包化、药物相互作用等管理	薬剤師；设施内部分环节由看護職管理	薬剤師免許	否/部分
服药	对姓名、时间、药物等核对，准备当次药物	看護職为主要专业责任人	看護師/准看護師允许	是
服药	把已准备好的药交给老人、辅助吞服、确认是否服下	介護職或看護職，依施設规则	介护资格/护理允许	是
服药	发现拒药、呕吐、嗜睡、低血压等异常并上报	介護職观察→看護職/医师判断	同上	是
移乘与体位	评估站立、平衡、关节活动、可承重程度	PT/OT＋看護職	PT/OT国家资格、护理允许	是
移乘	检查轮椅刹车、脚踏板、床高、移位辅具	介護職員	介护资格；福祉用具培训常见	是
移乘	床↔轮椅、轮椅↔马桶等实际转移	介護職員	介护资格	是
移乘	定时体位变换、皮肤受压观察	介護職＋看護職	介护资格/护理允许	是
康复与生活功能训练	身体功能、步行、ADL、认知/吞咽等专业评估	PT/OT/ST	相应国家允许	是
康复	制定个别康复目标及训练方法	PT/OT/ST＋医师＋照护团队	相应专业资格	是
康复	步行、关节、上肢活动、生活动作或吞咽训练	PT/OT/ST	相应国家允许	是
康复	把“训练”嵌入穿衣、如厕、进食等日常生活	介護職在PT/OT/ST方案下执行	介护资格	是

工作项目	可操作微步骤	通常负责职业	必需/常见资格	直接护理
营养与口腔	营养风险、体重变化、摄食量评价	管理栄養士/栄養士	管理栄養士/栄養士资格	否/部分
营养	菜单、能量、蛋白、水分、软食/刻み食等设计	管理栄養士+調理員	营养专业资格；调理师证常见但并非所有岗位必需	否
口腔	刷牙、义齿拆洗、餐后清洁	介護職；复杂问题由歯科衛生士等	介护资格；歯科衛生士免許	是
环境与后勤	铺床、换普通床单、整理居室、补充用品	介護助手/介護補助者	通常无国家资格	否
后勤	地面、公共区、家具清洁消毒	清掃員/介護助手	通常无国家资格	否
后勤	配膳、下膳、餐具整理、餐车回收	介護助手/調理補助	通常无国家资格	否
后勤	洗衣、污衣回收、分类、储物补充	洗濯/清掃/介護助手	通常无国家资格	否
记录与交接	每班记录进食、排泄、睡眠、活动、异常	介護職/看護職	各自岗位资格	否
交接	早晚班口头/电子交接，突出风险和状态变化	介護職+看護職	同上	否
照护计划	汇总需求、目标、服务内容并形成施設ケアプラン	介護支援専門員	介護支援専門員资格	否
照护计划	定期监测、召开多专业会议、修改计划	ケアマネ+各专业	对应专业资格	否
家属与社会协调	入住说明、合同、需求和家庭背景掌握	生活相談員/支援相談員	特养资格条件由地方规定；社会福祉士等常见	否
家属沟通	状态变化、生活问题、投诉等日常沟通	相談員+介護職/看護職	依岗位	否
出院/退所	医疗、居宅服务、家庭环境和后续照护协调	ケアマネ/支援相談員/看護職	相应资格	否
夜间与紧急处理	巡视、翻身、夜间排泄、呼叫铃处理	夜勤介護職	介护资格	是
紧急	首先发现跌倒、发热、呼吸异常、意识改变	介護職→立即通知看護職	介护资格；急救培训	是
紧急	临床评估、生命体征、医生联系、是否急救送院判断	看護職+医师	看護/医师免許	是
紧急	119、AED/BLS、家属通知、事故记录	当班人员+看護職+管理者	BLS/AED培训常见；医疗判断由持证专业人员负责	是

沐浴护理尤其能说明日本的特点。厚劳省关于入浴介助的培训资料强调“尊严保持”和“自立支援”，所以标准操作并非单纯“把老人洗干净”，而是从能力评估、本人可自己完成哪些动作、移乘风险，到洗浴和浴后状态连续观察。¹⁰

环境后勤则正是当前日本最积极实施“任务切分”的区域。厚劳省在介护生产力提升资料中明确举出**食事准备、片付け、清扫、ベッドメイク**等作为介護助手可承接的工作，其目的就是让有经验的介護職把工作时间重新集中到身体介护、观察、沟通和判断上。¹¹

职业画像与资格边界

这里要特别区分“**职业岗位**”与“**资格证书**”。例如“介護職員”是岗位，而“介護福祉士”是国家资格；并不是所有介護職員都必然是介護福祉士。相反，“看護師”“PT”“OT”等岗位本身就与法定专业资格高度绑定。

职业/岗位	主要功能	必需或典型资格	典型班次	直接护理	医疗背景
介護職員	ADL身体介护、观察、生活支援、记录、夜间照护	岗位并非一律要求国家资格； 介護福祉士 最常见，另有実務者研修、初任者研修；无相关资格者涉及认知症基础培训要求	早番/日勤/遅番/夜勤轮班	是	否
介護福祉士	通常仍在介護職岗位工作，但具国家专业资格，可承担更高难度护理、带教等	介護福祉士国家资格	轮班居多	是	否，属福祉专业
看護師・准看護師	健康评估、生命体征、伤口、服药、医疗处置、医生联络、急变判断	看護師/准看護師免許	特养常见日勤＋オンコール；老健/介护医疗院较可能轮班，依施設而定	是	是
医師	诊断、处方、疾病管理、急变和看取医疗决策	医師免許	日勤/定期诊疗＋オンコール；介护医疗院配置要求更高	是	是
薬剤師	调剂、药物管理、相互作用、药物信息	薬剤師免許	日勤为主	少量	是
PT	步行、肌力、关节、移动能力	理学療法士免許	日勤	是	是，康复
OT	穿衣、进食、如厕、上肢、认知等生活活动	作業療法士免許	日勤	是	是，康复
ST	言语、认知沟通、吞咽评价及训练	言語聴覚士免許	日勤	是	是，康复

职业/岗位	主要功能	必需或典型资格	典型班次	直接护理	医疗背景
機能訓練指導員	特养等的功能训练岗位	需由法律认可的专业资格者担任，如PT/OT/ST、看護职、柔道整復師等	日勤	是	视原资格
管理栄養士/栄養士	营养评估、菜单、饮食形态、多专业营养管理	管理栄養士/栄養士资格	日勤	通常否	健康专业
介護支援専門員（ケアマネ）	评估、施設ケアプラン、多专业协调、监测	介護支援専門員资格	日勤为主	通常否	否
生活相談員/支援相談員	入退所、家庭协调、投诉、社会资源、机构外联络	全国没有单一统一证照形式；社会福祉士、社会福祉主事任用資格等常见，具体受地方标准影响	日勤	通常否	否
計画作成担当者	Group Home认知症照护计划	GH每单元配置；规定数量中至少一人须为介護支援専門員	日勤为主，可兼介护职	角色本身否	否
介護助手/介護補助者	铺床、清洁、配膳、整理、物品补充等	通常无国家资格	日勤/短时间班较常见	原则否	否
調理員	烹调、配餐、厨房卫生	岗位不一定要求調理師证；专业厨房常见持证人员	早番～日勤	否	否
清掃・洗濯人員	清洁、消毒、污衣、洗衣	通常无国家资格	日勤/短班	否	否
事務員	保险结算、收费、人事、采购、行政	无养老行业统一国家资格	日勤	否	否
管理者/施設長	人员、质量、安全、合规、经营	按服务类型不同；GH等存在经验及专门研修要求	日勤+紧急联络	通常否	否

特养的生活相談員、介護职、看護职、管理者、ケアマネ等属于法定人员体系；其中生活相談員具体资格认定可能受到地方政府条例和“同等能力”认定的影响，因此不能简单理解为只有某一个全国统一证书才能任职。

12

老健则在这一体系上明显增加医疗和康复色彩；介護医療院更进一步，厚劳省列出的正式人员包括医师、药剂师、看護師/准看護師、介護職、PT/OT/ST、营养师、ケアマネ、放射线技师以及調理、事务等。

13

人员配置参考

这里最容易产生误解。日本法规中的“3对1”“6对1”多数是**常勤换算（FTE）配置标准**，不是指“白班现场随时有1名员工对3名老人”。例如介護医療院明确把全体该岗位人员的总工作时间除以设施全职员工规定工作时间，换算为FTE。¹⁴

公开官方资料也没有一张适用于全国所有机构、能够精确告诉我们“20床必须雇多少总人数、50床必须多少总人数”的实际排班表。因此下面优先采用**法定最低配置换算**。实际机构为了夜班、休假、培训、病假以及较高护理需求，实际雇员人数与同时在岗数会另行设计。

类型	20名入住者参考	50名入住者参考	100名入住者参考	关键解释
特养：介護职 + 看護职合计	≥约6.7 FTE	≥约16.7 FTE	≥约33.3 FTE	基本3:1；其中看護职另有规模最低配置。 ⁴
特养：看護职最低规模参考	≥1	≥2	≥3	30人以下1名、31-50约2名、51-130约3名；超大规模再增加。 ¹⁵
特养：生活相談員	≥1	≥1	≥1	原则以100名入住者约1人为基本配置。 ¹⁶
特养：ケアマネ	≥1	≥1	≥1左右	100人规模通常以1人为基本标准；另有機能訓練指導員等岗位
老健：看護 + 介護合计	≥约6.7 FTE	≥约16.7 FTE	≥约33.3 FTE	同样约3:1，但内部结构通常以看護约2/7、介護约5/7作为标准性参考。 ¹⁷
老健：其中看護职约	≈1.9 FTE	≈4.8 FTE	≈9.5 FTE	按上述2/7参考计算，不宜视为独立刚性比例
老健：其中介護职约	≈4.8 FTE	≈11.9 FTE	≈23.8 FTE	按上述5/7参考计算
老健：医师	通常至少1名常勤	至少1名常勤	约100:1且至少1名常勤	老健与普通特养最大的制度差异之一。 ¹⁷
老健：PT/OT/ST合计	≈0.2 FTE级	≈0.5 FTE级	≈1 FTE级	按100名入住者约1 FTE基准理解，实际康复强化型设施可明显更多。 ¹⁸
介護医療院Ⅱ型：看護职	≥3.3 FTE	≥8.3 FTE	≥16.7 FTE	明确为6:1。 ¹⁹
介護医療院Ⅱ型：介護职	≥3.3 FTE	≥8.3 FTE	≥16.7 FTE	Ⅱ型为6:1。 ¹⁹
介護医療院Ⅰ型：介護职	≥4 FTE	≥10 FTE	≥20 FTE	Ⅰ型为5:1，比Ⅱ型更密集。 ¹⁹
介護医療院Ⅰ型：医师	原则设施≥3	≥3	≥3	Ⅰ型48:1且普通形态设施原则至少3名；併設小规模等存在例外。 ¹⁹
介護医療院Ⅱ型：医师	原则≥1	≥1	≥1	Ⅱ型约100:1、设施至少1名，特殊併設情形另有规则。 ²⁰

类型	20名入住者参考	50名入住者参考	100名入住者参考	关键解释
介護医療院： ケアマネ	≥1	≥1	≥1	专任常勤至少1；100人或其端数增加时以增员为标准。 ¹⁴

Group Home不能简单用20/50/100床推算。它本质是“小单元”制度。厚劳省当前资料规定，介護従業者在日间按**入住者3人：1人**配置，夜间原则上**每个ユニット至少1人**；計画作成担当者则每单元1人，并且规定人员中至少1人为介護支援専門員。因此，若按典型9人单元理解，9/18/27名入住者大致对应日间介护配置3/6/9 FTE量级，而夜间最低同时配置大致为1/2/3人，实际还受到单元设置和例外规则影响。⁶

这个配置表也说明了一个重要现象：**日本的专业分工随着“医疗依赖度”而明显变化。**从Group Home→特养→老健→介護医療院，医师、看護、药剂、康复人员的占比逐渐提升，而并不是把“洗澡的人、喂饭的人、换尿布的人”依次增加成独立职业。²¹

执行规范与流程控制

日本机构真正“细”的地方，更多体现在每个动作都有**前置确认—实际执行—观察—记录—异常升级**的闭环，而不是仅仅“谁来干”。

工作	常见执行规范/控制点	主执行者	专业监督/异常判断
沐浴	入浴前状态确认；本人能做的动作尽量自己完成；移动防跌；防烫伤；保护隐私；洗浴中观察皮肤；浴后补水和复评	介護職	看護職；厚劳省强调尊严、自立支援导向。 ¹⁰
排泄	隐私遮挡；手卫生/PPE；清洁区与污染区分开；观察尿便和皮肤；及时更换；异常及时上报	介護職	看護職负责皮肤、感染、血尿/便血等临床判断
进食	先确认食形；稳定坐姿；控制一口量和速度；观察咳嗽、声音变化、残留；记录进食/饮水量	介護職	ST、看護職、管理栄養士
服药	对人、药、时间、剂量等核对；很多设施采用二重チェック；给药后确认吞服；漏服/拒药立即报告；介護職不得自行改变处方	看護職＋介護職	医师/药剂师/看護職；“二重チェック”属于常见事故防止措施，具体方法由设施SOP决定，并非所有机构采用完全同一形式。日本养老现场已有专门的与药事故防止培训。 ²²
移乘	先确定剩余能力；刹车和脚踏板检查；选择站立、滑板、升降机等方法；避免硬抱硬拉；完成后确认坐姿	介護職	PT/OT设计方法，看護職处理医学风险
康复	先评价再训练；设个人目标；专业训练与日常ADL结合；避免“康复时间才训练、其他时间全部代劳”	PT/OT/ST＋介護職	康复专业人员/医师
环境工作	区分直接护理与可转移的间接任务；床单、配膳、清扫等尽量交给辅助人员	介護助手等	介護リーダー/管理者；这是厚劳省当前任务切分的重要方向。 ¹¹

工 作	常见执行规范/控制点	主执行 者	专业监督/异常判断
记 录 交 接	做了什么、老人反应、异常、尚未完成事项进入记录；下一班必须能识别高风险事项	介護職/看護職	介护主任、看護负责人、ケアマネ
紧 急 事 件	第一发现→确保安全/生命体征→通知看護→医生或119→家属→事故记录和复盘	当班介護職开始	看護師、医师、管理者
照 护 计 划	Assessment→目标→服务方法→各专业执行→监测→多专业会议→修改计划	ケアマネ	多专业团队；GHの計画作成担当者も承担类似持续监测功能。 ²³

因此，一次“喂饭”在管理系统里实际上可能被拆成：

食形确认 → 老人身份确认 → 坐姿调整 → 餐具设置 → 自食能力确认 → 必要部分介助 → 吞咽观察 → 水分摄入 → 摄入量记录 → 口腔清洁 → 异常交接。

但这里往往不是10个职业各负责一步，而更可能是：

管理栄養士/ST决定规则 → 看護職负责医学风险 → 介護職连续执行多个生活护理步骤 → 介護助手负责送餐、收餐盘和环境恢复 → 结果进入记录供ケアマネ及团队复盘。

这正是日本机构养老中“细颗粒度”的实质。

结论与来源可信度

日本机构养老最值得借鉴的，不是把每个微动作都做成一个新的职位，而是形成了“专业资格边界+SOP微步骤+多专业计划+间接任务外移+记录反馈”的体系。介護職仍然是综合型一线照护者；真正明显专门化的是医师/看護、康复、营养、相談、ケアマネ等专业领域，以及近年来快速发展的介護助手、清扫、配膳、铺床等辅助岗位。换句话说，一个较合理的日本式拆解模型是：需要判断和身体接触的核心照护由受训介護職承担；涉及医疗、康复、营养和照护设计的事项交给对应持证专业人员；可标准化、低风险、非身体照护的工作尽量交给辅助人员。²⁴

本报告的可信度排序为：第一优先级：厚生劳动省、e-Gov法令及官方服务资料，用于判断人员配置、制度状态和法定岗位；第二优先级：WAM NET、全国老人保健施設協会等准官方/全国行业组织的法规数据库；第三优先级：都道府县和市町村的指定、检查指南，用于理解地方执行；第四优先级：行业运营资料和专业培训资料；招聘网站、媒体案例仅用于说明典型班次、常见资格或“105项任务拆解”等实际运营案例，不作为全国性法规依据。特别是“每20/50/100床的实际雇员人数”和“某一步必须由唯一某岗位完成”这两类数据，日本并无全国统一公开标准，因此本文明确以法定最低FTE+常见实践呈现，而没有把个别机构做法误写成全国规则。²⁵

¹ ⁷ ⁸ ¹³ ¹⁴ ²⁴ 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について — 老老発0322第1号 | 通知 | 1999 | 法令・Q&A検索システム 全老健介護保険制度情報サービス
<https://hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=1999>

- 2 3 6 11 21 介護保険最新情報 Vol.1219 令和6年3月 15 日
https://www.mhlw.go.jp/?utm_source=chatgpt.com
- 4 12 16 25 13 介護老人福祉施設 <人員基準のポイント ... - 埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/?utm_source=chatgpt.com
- 5 施設及び設備並びに運営に関する基準について - 老企第44号 ...
https://hourei.roken.or.jp/?utm_source=chatgpt.com
- 9 認知症介護基礎研修の義務化とは？対象者・期限・受講方法を ...
https://si-academy.jp/?utm_source=chatgpt.com
- 10 「尊厳の保持・自立支援に資する入浴介助を行うために～通所系 ...
https://www.youtube.com/watch?v=WhmijBwQnF0&utm_source=chatgpt.com
- 15 【2026年版】特別養護老人ホーム（特養）完全ガイド～施設長が ...
https://doctormate.co.jp/?utm_source=chatgpt.com
- 17 老健（介護老人保健施設）とは？施設要件、特徴、スタッフの ...
https://job-medley.com/?utm_source=chatgpt.com
- 18 介護老人保健施設（老健）の人員配置基準とリハビリ職の配置
https://kaigo-staffing-guide.com/?utm_source=chatgpt.com
- 19 20 介護医療院とは - 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/kaigoiryuin/about/?utm_source=chatgpt.com
- 22 令和5年 第1回 介護事故の予防について ～与薬事故～
https://www.youtube.com/watch?v=bWnahNcCqv&utm_source=chatgpt.com
- 23 認知症対応型共同生活介護 - 横浜市
https://www.city.yokohama.lg.jp/?utm_source=chatgpt.com